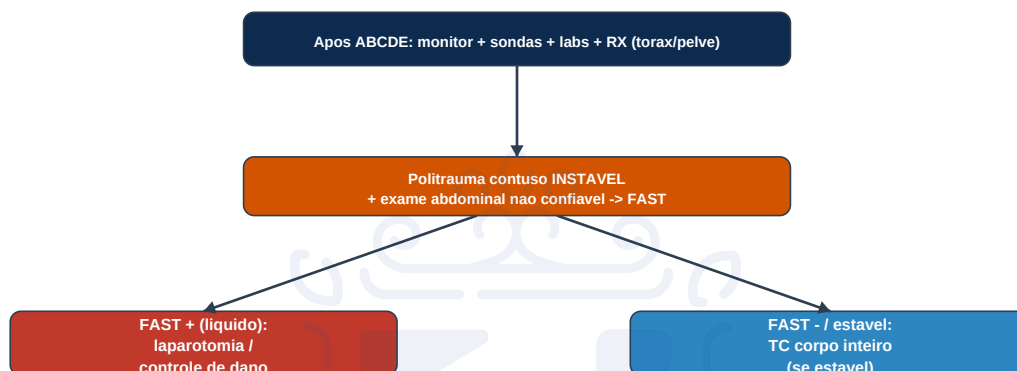


TRAUMA — MEDIDAS AUXILIARES E FAST

FLUXOGRAMA — ADJUNTOS DA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

FAST DEFINE CONDUTA NO INSTÁVEL



MONITORIZAÇÃO E SONDAS

ADJUNTOS BÁSICOS

- Monitorização: SatO₂, PA, FC, cardioscopia; CAPNOGRAFIA = padrão-ouro para confirmar IOT
- Sondagem VESICAL: controle de diurese no trauma grave. Contra: URETRORRAGIA (chamar especialista/uretrocistografia)
- Hematúria e alteração prostática NÃO contraindicam; fratura de pelve e lesão perineal = contraindicação RELATIVA
- Sondagem GÁSTRICA: todo paciente que vai ser intubado (alivia distensão, reduz broncoaspiração e resposta vagal)
- Suspeita de fratura de BASE DE CRÂNIO contraindica a via NASOGástrica (preferir orogástrica)

EXAMES LABORATORIAIS E IMAGEM

O QUE PEDIR

- SEMPRE: tipagem sanguínea e Rh, gasometria arterial, beta-hCG em mulheres em idade fértil
- CONSIDERAR: hemograma, coagulograma, plaquetas, provas de função orgânica
- RX: NUNCA atrasar transferência/tratamento; RX de TÓRAX e de PELVE fazem parte da avaliação primária
- RX de cervical em casos selecionados; demais radiografias sob demanda
- TC de corpo inteiro: apenas no ESTÁVEL (reduz mortalidade/erro em trauma grave — alta energia, queda de altura, atropelamento)

FAST / E-FAST — INDICAÇÃO

FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA

- Rápido, barato, à beira-leito, portátil; complementa o exame físico (detecta ~200 mL de líquido em 1 min)
- INDICAÇÃO: politraumatizado com trauma CONTUSO, exame abdominal não confiável e INSTABILIDADE hemodinâmica
- FAST positivo no instável = DEFINE CONDUTA (laparotomia/controle de dano)
- Mais sensível que o RX e mais rápido que a TC
- 50% dos traumas graves não têm exame físico abdominal confiável

JANELAS DO FAST

Janela	Localização	Avalia
Hepatorrenal (Morrison)	Linha axilar média, 12a costela à direita	Líquido livre (a + sensível)
Esplenorrenal	Linha axilar posterior, 10a costela à esquerda	Líquido livre
Suprapúbica	1-2 cm acima do púbis	Líquido livre pélvico
Pericárdica (subxifoide)	Subxifoide	Derrame pericárdico/tamponamento
Pulmonares (E-FAST)	Âpices e bases bilaterais	Pneumotórax e hemotórax

E-FAST PULMONAR — ACHADOS

PNEUMOTÓRAX E HEMOTÓRAX

- Lung sliding presente (sinal da PRAIA) = pleuras deslizando = normal
- Ausência de lung sliding (sinal do CÓDIGO DE BARRAS) = sugestivo de pneumotórax (não confirma isoladamente)
- LUNG POINT = ponto de parada abrupta do sliding = PATOGNOMÔNICO de pneumotórax
- Hemotórax: líquido (anecóico/preto) acima do diafragma
- Linhas A (horizontais) = normal; linhas B (verticais) acompanham o lung sliding

LIMITAÇÕES DO FAST (falsos-negativos)

ONDE O FAST FALHA

- Retroperitônio, vísceras ocas e lesões de aorta
- Laceração pericárdica, derrame pleural
- Enfisema de subcutâneo, obesidade, mau posicionamento
- FAST negativo NÃO exclui lesão — no estável, complementar com TC
- No instável com FAST negativo persistente, buscar outras fontes (pelve, tórax, externo)

CHECKLIST DOS ADJUNTOS

APÓS O ABCDE

- ☐ Monitorização completa + capnografia se intubado
- ☐ Sonda vesical (chechar uretrorragia) e gástrica (orogástrica se suspeita de fratura de base de crânio)
- ☐ Tipagem/Rh, gasometria, beta-hCG; RX de tórax e pelve
- ☐ FAST no instável com trauma contuso (define laparotomia); TC de corpo inteiro só no estável
- ☐ Nunca atrasar a transferência para fazer exames

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Politrauma por ____; FAST: positivo/negativo (janela ____); E-FAST: pneumo/hemotórax?
- RX tórax/pelve: ____; sondas (vesical/gástrica): ____; tipagem solicitada.
- Estabilidade hemodinâmica: ____; conduta definida pelo FAST: ____ (laparotomia/observação/TC).
- Solicito transferência a centro de trauma; estabilizar antes de transferir.



FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Politraumatizado por trauma contuso, instável, com exame abdominal não confiável. Qual exame define a conduta à beira-leito?

- A) Tomografia de corpo inteiro imediata
- B) FAST (positivo indica laparotomia/controle de dano)
- C) Ressonância de abdome
- D) Lavado peritoneal de rotina
- E) Aguardar estabilização para qualquer imagem

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é uma contraindicação à sondagem vesical no trauma?

- A) Hematúria microscópica
- B) Uretrorragia (sangue no meato uretral)
- C) Alteração prostática
- D) Diurese reduzida
- E) Dor abdominal

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado ultrassonográfico é patognomônico de pneumotórax?

- A) Lung sliding presente
- B) Lung point (ponto de parada abrupta do deslizamento pleural)
- C) Linhas B abundantes
- D) Sinal da praia
- E) Líquido na janela de Morrison

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais radiografias fazem parte da avaliação primária do trauma?

- A) Crânio e coluna lombar
- B) Tórax e pelve
- C) Mãos e pés
- D) Seios da face
- E) Abdome agudo em 3 incidências

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando a sonda gástrica deve ser passada por via OROgástrica em vez de nasogástrica?

- A) Sempre que houver hematúria
- B) Na suspeita de fratura de base de crânio
- C) Em fratura de fêmur
- D) Em pneumotórax
- E) Nunca há diferença

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No trauma contuso instável com exame abdominal não confiável, o FAST é o exame que define a conduta à beira-leito: se positivo (líquido livre), indica laparotomia/controle de dano. A TC fica para o estável.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A uretrorragia (sangue no meato) contraindica a sondagem vesical às cegas (risco de falso trajeto em lesão uretral) — chamar especialista/uretrocistografia. Hematúria e alteração prostática não contraindicam; fratura de pelve é contraindicação relativa.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O lung point (transição abrupta entre área com e sem deslizamento pleural) é patognomônico de pneumotórax. A ausência isolada de lung sliding é sugestiva, mas não confirma (ocorre em IOT seletiva, fibrose, etc.).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

As radiografias de TÓRAX e de PELVE integram a avaliação primária do trauma (detectam lesões torácicas e fraturas pélvicas com sangramento). Demais radiografias são feitas sob demanda.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na suspeita de fratura de base de crânio, evita-se a via nasogástrica (risco de passagem intracraniana) e prefere-se a sonda OROgástrica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico